항혈전제 복용자 내시경 전 상담표

아스피린·플라빅스·와파린·엘리퀴스 같은 약은 출혈을 늘릴 수 있지만, 임의로 끊으면 심근경색·뇌졸중·스텐트 혈전 위험이 커질 수 있습니다. 약 중단 여부는 검사 종류와 혈전 위험을 함께 보고 의료진이 결정합니다.

1단계 — 복용 중인 약을 모두 알려 주세요

항혈소판제 · 피가 엉기는 것을 막는 약	항응고제 · 혈전이 생기는 것을 억제하는 약
아스피린	와파린
클로피도그렐 (플라빅스)	아픽사반 (엘리퀴스)
프라수그렐 (에피언트)	리바록사반 (자렐토)
티카그렐러 (브릴린타)	에독사반 (릭시아나)
실로스타졸 (프레탈 등)	다비가트란 (프라닥사)

2단계 — 상담 때 꼭 확인할 5가지

1. **검사 종류** — 단순 관찰·조직검사인지, 용종절제·점막절제처럼 출혈 위험이 높은 시술인지 확인합니다.
2. **약 이름·용량·마지막 복용 시간** — 약 봉투, 처방전, 복약 앱 사진을 가져오세요.
3. **왜 먹는 약인지** — 심장 스텐트, 뇌졸중, 심방세동, 혈전증, 판막수술 여부가 중요합니다.
4. **최근 사건** — 1년 이내 심장 스텐트·심근경색·뇌졸중·폐색전증이 있었다면 반드시 먼저 알려 주세요.
5. **콩팥 기능·피 응고 수치(INR)** — 먹는 항응고제는 콩팥 기능, 와파린은 INR 결과에 따라 검사 일정이 달라질 수 있습니다.



박중철 강의: 스텐트 보조 코일색전술 후 이중 항혈소판요법을 통상 3~6개월 유지합니다. 내시경 시점과 약 중단은 협진으로 결정합니다.
(아산28 · 검진에서 발견된 뇌동맥류: 어떻게 추적하고 언제 치료할까?(박중철))

하지 스텐트 · 병합요법 기간의 강의 예시이며, 내시경 전 약 중단 일정은 협진으로 따로 정합니다. 김태오 연자: 아스피린+클로피도그렐은 보통 1~3개월(길어야 6개월) 병용 후 단일 항혈소판제를 유지합니다. 평생 유지하는 것은 병합요법이 아니라 단일제입니다.
김태오 연자 Q&A: 은행잎 제제까지 복용하며 멍이 생겼던 사례에서는 약을 늘리기보다 복용약을 먼저 정리했습니다.
(아산28 · 말초동맥질환, 언제 의심하고 어떻게 치료할까?(김태오))

검사 종류별 원칙 — 스스로 정하지 마세요

	출혈 위험 낮은 검사	출혈 위험 높은 시술
예	진단 위내시경·대장내시경, 단순 조직검사	용종절제, 내시경 점막절제술·점막하박리술, 내시경 지혈·확장술
원칙	많은 경우 **약을 유지하거나 최소 조정**으로 진행합니다. 먹는 항응고제는 검사 당일 아침 복용 여부를 의료진이 확인합니다.	약제별 조정이 필요할 수 있습니다. 스텐트·뇌졸중 위험이 높으면 **처방의와 상의 후 결정**합니다.

⚠ **절대 하지 마세요** — 인터넷 표만 보고 약 끊기 · 스텐트·뇌졸중 약 임의 중단 · 약 이름을 모른 채 검사 당일 내원 · 중단한 뒤 재개일을 확인하지 않기

내원 전 준비 — 약 봉투 또는 처방전 사진 · 심장 스텐트 시술 날짜 · 최근 뇌졸중·혈전증 진단일 · 최근 콩팥 기능 검사(크레아티닌·사구체여과율), 와파린 복용자는 INR(피 응고 수치)

함께 보기 — 약마다 다른 점(진료실 자료 '항혈전제 바로 알기'): edu.gwanggyobarun.com/decks/cardio/antithrombotic-therapy/overview/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — BSG/ESGE 2021 · 한국소화기내시경 항혈전제 가이드라인 2020 · ASGE

본 자료는 사전 상담을 돕기 위한 안내문입니다. 항혈전제 중단·재개 일정은 담당 의사와 처방의가 환자별로 결정합니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/antithrombotic-pre-endoscopy/